

12주차

2장 월경통과 골반통 p.90 *ppt 수업

1절 월경곤란증

1. 개요

- ★ (소복통)은 골반통과 관련이 깊다. 소복부에 연접한 여성의 전음은 중근이 모이는 곳이며, 태음경맥과 양명경맥이 합쳐진다 '05

[1] 정의

- 월경통은 월경기간 혹은 월경기간을 전후하여 나타나는 하복부와 치골상부의 동통
- 월경통을 포함한 월경에 수반되어 일어나는 병적 증상을 총칭해서 월경곤란증 (dysmenorrhea)이라고 한다.
 - PMS를 포함하고 있는 개념이라고 볼 수 있음. (월경 주기와 관련된 모든 증상 포괄)
- 월경통은 하복통 소복통의 범주만을 이야기 (원칙적으로 요통, 골반통까지는 월경통이라고 볼 수만은 없으나 골반전체의 통증까지는 월경통으로봄. 그러나 월경기간에 나타나는 두통은 월경통이라고 말하진x)
- 한의학적 표현 : 통경 경행복통 경기복통

[2] 분류

- ★ 월경곤란증은 두 가지로 나뉘는데, (원발성 월경곤란증)은 골반 내에 기질적인 병변이 없이 유발되나, (속발성 월경곤란증)은 골반 내 근원적인 병적상태가 있다 '05

분류	내용/질환	¹ 기질적 병변 유무★
원발성	주로 초경 1-2년 이내 (중요x)	없음
속발성	² 자궁내막증, 자궁샘근증, 자궁근종, 자궁 내용종, ³ PID, ⁴ IUD	있음

- ① 기질적 병변: 자궁 및 자궁내막의 문제를 의미
- ② 보통 자궁내막증, 자궁샘근증이 가장 문제가 되는 질환임.
- ③ PID는 골반 전체가 염증 상황이므로 월경이 있을 때 더 심해짐.(월경이 없을 때도 통증 有)
- ④ IUD는 주로 출혈이 문제가 되고, 월경통을 일으킬 수는 있음.

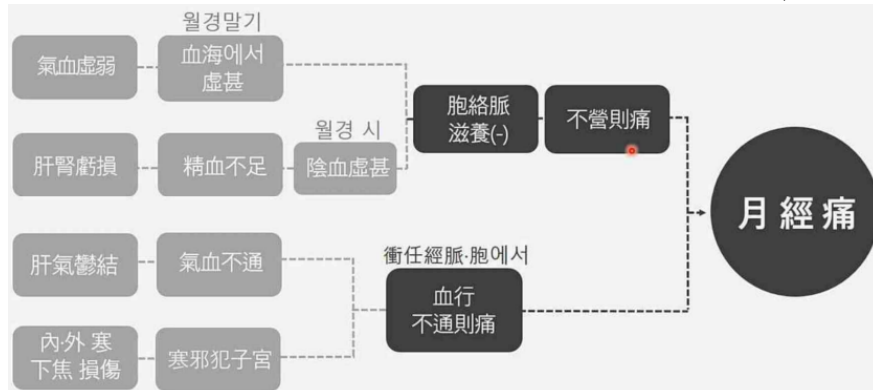
[3] 발생률

- 50%: 월경기 전 여성 (반절이 아픈 상태로 높은 발생률을 보이고 있음.)
- 15%: 원발성 월경곤란증 업무/학업/일상생활 불가 (원발성 월경통은 치료 잘되는 편)
- 30%: 진통제 등의 약물 복용

2. 병인병기

1) 한의학의 월경통 병리

★ 월경통의 허실에 따른 병인병기 두 가지를 한자로 쓰시오
不營則痛, 血行不通則痛 '04,05



↑ 위의 그림 설명

허증	기혈허약, 간신히손으로 인해 포락맥을 자양하지 못하여 불영즉통(不營則痛)
실증	① 간기울결로 기혈이 불통 ② 양허로 인한 내한 ③ 외부 한사 침입으로 인한 외한 이 3가지로 인해 하초손상 (한습조체) → 혈행불통즉통(血行不通則痛)

*허증은 영양을 받지 못해서 나타나는 월경통, 실증은 통하지 못해서 나타나는 월경통.

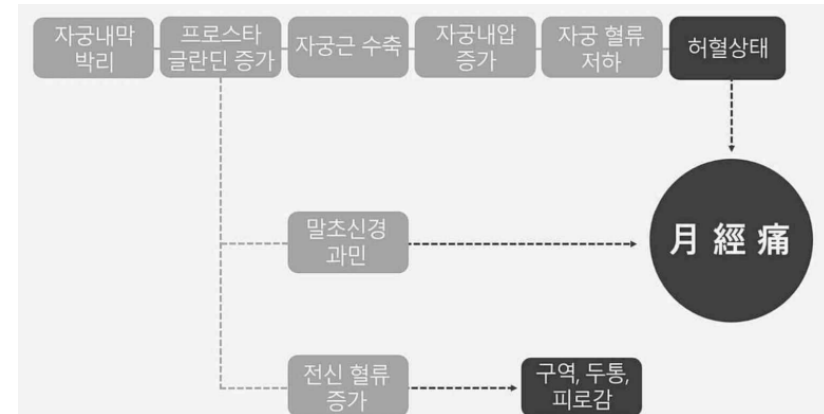
- 임상에서는 불영즉통으로 인한 기전이 덜 주목받음.

→ BUT 실제로 불영즉통(허증)과 혈행불통즉통(실증)은 상호전환적인 관계

→ 허실협잡으로 일어나지만, '어느쪽에 %를 높게 둘 것인가'가 변증의 요지가 됨.

2) 서양의학의 (원발성) 월경통 병리

★ 황체호르몬의 영향으로 자궁내막에서 합성되며 수축, 자궁혈류량 감소 및 자궁근 수축 등의 작용 임상 상 월경통과 관련이 있는 호르몬은? 04 프로스타글란딘



- 가장 문제되는 것은 '프로스타글란딘'의 증가 → 자궁근 수축 과다 & 허혈 → 월경통

① 프로스타글란딘은 항상 만들어지나, P가 소퇴(수직낙하)할 때(월경기 직전~첫날) 특히 증가함.

② 자궁은 늘어나는 방향으로 통증이 없으며, 수축할 때 통증이 생김.

- 전신의 혈류 증가 = 담음에 해당

★프로스타글란딘 PG → 길게 설명하셔서 알아두기

- 어원: 월경통의 주범이라는 의미

→ 남자의 정액에는 자궁을 수축시키는 인자(전립선에서 나옴)가 있는데 여기서 유래

1) PG의 기전

- 프로스타글란딘이 증가하기 위해서는 프로게스테론이 증가해야 하고 이를 위해서는 배란이 일어나야 함. 이후 프로게스테론이 떨어지면 COX(싸이클로 옥시게나제)가 나오고 프로스타글란딘이 나옴. 이때 Fα가 제일 문제가 됨.

→ COX를 억제하여 월경통을 방지하고자 함.

2) COX의 종류

- COX-1 ①PG E2 (위산분비억제, 위점막보호)

②TBX A2 (위장관 출혈 방지, 혈소판 응고)

→ COX-1은 위장관 보호 역할

- COX-2 ①PG F2α (병리적 상황 유도, 염증 상황 발현)

②Prostacyclin (트롬복산과 반대로 작용하여 혈액순환 촉진, 혈관 확장)

3) 약물의 종류와 부작용

(1) 이부프로펜 제제(NSAIDs): COX 기전을 막아 진통하는 약(말초성 진통제)

[기전] COX-1, 2를 비선택적으로 억제함 → 해열, 진통, 소염의 효과

+ 비슷한 약물인 아스피린은 COX 생성 자체를 차단하는 강력한 약임.

→ 아스피린 외 다른 비선택적 COX 억제 약들은 COX 활성화를 막는 기전에 해당.

[부작용] ① COX-1까지 제거하여 위장관 부작용 유발 + 출혈 가능성 (위장관 출혈)

② 신장독 → 신독성이 간독성에 비해서는 덜 위험하므로 그럼에도 권장됨.

(2) 아세트아미노펜: COX-2 억제제(Coxib)

- 이부프로펜 제제의 부작용 때문에 COX-2만 선택적으로 억제하는 약을 개발하였음.

- 특히 중추에 작용하는 약으로 해열제 목적으로 개발된 아세트아미노펜이 대표적인.

(이후 COX-2를 간접적으로 억제한다는 것이 밝혀지면서 해열진통제로 사용되기 시작함.)

[기전] COX-2를 간접적으로 억제함. → 해열, 진통의 효과 (소염은 X)

→ COX-1에 관여하지 않으므로 위장관 문제 가능성이 적음 ('빈속에 먹어라' 광고)

[부작용] ① 간독성이 큰 약물

② 심혈관 질환과 관련될 수 있다는 연구 有

→ 따라서 월경통에 타이레놀(아세트아미노펜)보다는 이지엔6(이부프로펜)을 추천함.

3) 속발성 월경통은 기저 골반의 병리 병태에 따라 기인함

유형	해당 질환 및 병태
유출로 폐색	- 월러관 기형 - 자궁경관협착 (원추절제 후 유착 등)
자궁내 병변	- 자궁근종 (주로 점막하근종) - 자궁내막용종 - <u>자궁샘근증</u> - 자궁내 피임장치
자궁외 병변	- <u>자궁내막증</u> - <u>골반염증성질환(=PID)</u> - 기왕의 골반부 수술 → 수술 자체가 문제가 되는 것이 아니라 수술 이후 유착이 문제가 됨. - <u>골반정맥 울혈</u> : <u>골반울혈증후군</u> (흔하지 않은 질환) → 혈류 과다로 인해 혈관이 늘어져서 발생

*임상에서 가장 문제가 되는 2가지: 자궁샘근증 & 자궁내막증

→ 두 질환은 초음파 없이도 감별할 수 있어야 함.

※자궁근종

1) 근층 내 근종 2) 점막 하 근종 3) 장막 하 근종

+ 4) 자궁내막용종(폴립)

- 자궁내막용종은 자궁내막의 조직이 과도하게 증식하는 것 / 자궁근종은 자궁의 근육이 비정상적으로 자라나는 것으로 차이가 있으나 자궁내막용종이 자궁근종에서 흔히 발견됨.

→ 정확히는 차이가 있으나 교수님께서 4가지로 말씀하셨습니다.

- 점막하근종이 가장 문제가 됨. (자궁내막이 자라는 방향 때문)

- 자궁내막용종은 부정자궁출혈을 유발함.

3. 임상양상

[1] 증후 양상

- 월경통 양상에 따른 특징 [★중요]

	원발성 월경곤란증	속발성 월경곤란증
호발 연령	초경 1~2년 내 발생 ¹ 미혼, 출산경력 없는 여성	² 30세 이후 유산과 출산 이후
통증 발생 시간	월경 시작 수 시간 전 / 시작 직후 ³ 무배란성 월경에는 거의X	⁴ 무배란성 월경에서도 발생 가능
통증 지속 시간	보통 월경전후 24시간 이내 발생 약 48- ⁵ 72시간 지속 월경 제1~2일째 심하다 하루 이내에 경감	⁵ 72시간 경과하는 경우 多
호전 시기	임신분만 후 증상의 개선/소실	원인질환의 개선에 따름
통증 특징	치골상부(소복)의 경련통 분만진통과 유사 간대성 통증 대퇴부로의 방산통이 흔함	원인질환에 따른 특징적인 증상 (근종, PID, <u>내막증</u> , <u>샘근증</u>)

- ① 원발성 월경통이 미혼/출산경력 없는 여성에서 호발하는 이유: 출산하는 동안(출산 2기)에 음부신경의 상당 부분이 터져나가므로 말초에서 통증을 느끼는 절대적인 수가 줄어들기 때문. 또 출산시 구멍(공간)이 넓어지므로 수축되는 정도가 줄어서 자연분만 산모에서 통증이 줄어들기도 함.
 - ② 예외적으로 자궁내막증은 30세 이전에 속발성 월경통이 나타날 수 있음.
→ 30세 이후는 자궁선근증, 30세 이전에는 자궁내막증이 호발함.
 - ③ 원발성 월경통은 주로 배란 시 증가하는 PG(프로스타글란딘)의 작용에 의해 발생함. 따라서 배란을 하지 않으면 PG도 증가하지 않으니, 무배란성 월경에서는 거의 나타나지 않음.
 - ④ 속발성은 기질적 병변(원인 질환)이 있기 때문에, 무배란으로 PG가 증가하지 않더라도 월경통 발생 가능.
 - ⑤ ★ **72시간의 법칙**: 월경통이 72시간 내에 소실하면 원발성이 확률이 높음.
- 속발성은 24시간 이전에 시작해서 월경 끝날 때까지 아픈 경우가 해당됨.
- 통증 자체도 속발성 월경통이 더 심함.
- *속발성 월경통을 가지고 있는 사람은 원인질환에 의한 통증을 가지고 있고, 여기에 프로스타글란딘에 의한 통증이 더해질 수 있음. (원발성과 속발성은 완전히 독립적인 것이 아님.)

- ⑥ 내막증: 월경량의 변화는 없으며, 자궁이 월경주기에 따라 크기가 변동하면서 월경통이 생기는 경향. 심하면 월경 개시 1주일 전~월경후 1주일간 아픈 경우도 있음. “한달의 절반 정도는 아프다”라는 환자들은 자궁내막증일 확률이 높음.

- ⑦ 샘근증: 월경량이 많으며, 월경량이 많은 기간에 아픈 경향

[2] 동반증후

(1) 일반적 동반증후

- **요통**, 복부팽만감, 구역, 두통, 피로감 등

+ 장자극이 있어서 장명 장운동향진 설사, 자율신경 반사로 인한 구역, 구토, 두통, 피로감

(2) 유형별 동반증후 ★

원발성 월경 곤란증	- 앞쪽 대퇴부로의 방산통 , 오심, 구토, 설사 - 드물게는 실신(미주신경성), 활력 징후 및 골반내 장기는 정상 - 응급실 가는 경우도 꽤 흔함.
속발성 월경 곤란증	원인 질환에 따라 월경과다(자궁샘근증의 특징), 부정 출혈(자궁내막증의 특징), 발열(PID), 성교통(자궁내막증에서 관찰됨) 등

- 자궁내막증에서 내막이 움직이면서 성교통이 생길 수 있음.(점상출혈도 발생 가능)



(3) 변증별 증상 ★★★ CPX 파일 참고

	허증		실증	
	기혈허약	간신후손 ★★★ '05,11,13	기체혈어 ★★★ '05,13,14,17,18	한습응체 ★★★ '05,11,13,15,17
증상	경기 경후 하복은은통, ¹ 추타 통, 회안, 경량혹다(기허) 혹소(혈허), 경기부정, 면색창백, 두훈, 심계	경후 하복은은통, 경량혹다혹소, 색연 질희, 요슬산통, 두훈이명, -소복청장(양허) -조열, 구건, 심번, ² 면천 (음허)	경전 1-2일 ³ 하복 창통, 유방창통, 흉협창만, 월경량소, 경색암자, 혈괴 다, 혈괴 배출후 통증 감소, 정신긴장, ⁴ 오심구토	경전 경기 하복 냉통 및 요통, ⁵ 득온즉완, 경량소, 경색암홍, 혈괴, 경기연장, 안색창백, 사지불온
설	설담홍 태박백	설담암/눈홍 태소	설암어점	설담암 태백활
맥	맥세약	맥침세약 척맥무력	맥현 혹 맥삽	맥침긴

- ① 추타통: 아래가 빠질 것 같은 통증으로, 월경통 증상으로는 흔치 않고 만성PID 환자인 경우가 많음.
- ② 면천: 수면이 얕다, 잠을 잘 못 잠
- ③ 창통: 월경통이 계속 있는 것이 아니라, 수축이 되는 시기에 경련하듯이 아픔
- ④ 오심구토: 자율신경반사의 영향
- ⑤ 득온즉완: 염증이 있어도 배를 싸안기 때문에, '득온즉완' 만으로 한열구분하지 말 것
ex. 맹장염이 있을 때 배를 감싸쥐고 응급실에 가고 배에 찜질도 하는데 이게 실증이 아니라
고 볼 수 있는가? → 즉, 단순히 이것으로 한열허실 구분X

- 혈괴: 괴형이 나가는 느낌이 드는지 문진을 하는 것이 좋음.

4. 진단

[1] 진단원칙

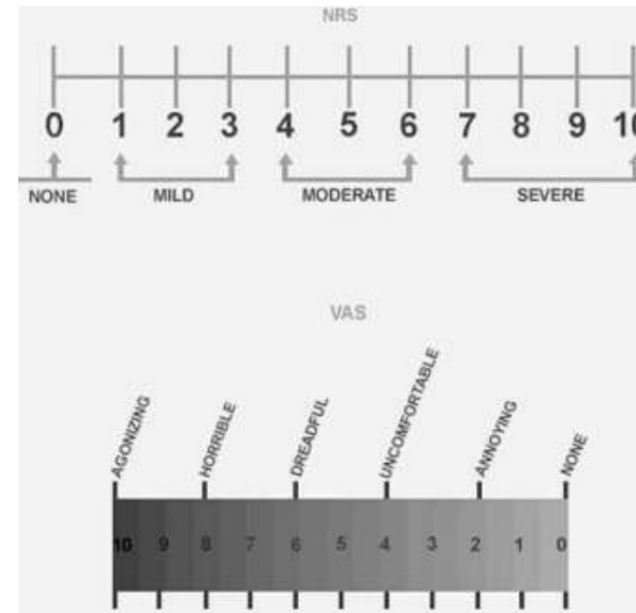
- 환자에게 증상이 나타나는 시점 → 즉, 월경전후가 적기

실제 임상에서는 환자가 월경 전후에 맞춰서 오지 않고, 본인 시간 날 때 오기 때문에 원칙대로만 할 수는 없음.

[2] 평가기준

초진할 때~ 치료하면서 치료경과 평가할 때도 이용함.

- 숫자통증척도 (NRS)
- 상사척도 (VAS)
- 다면적 구두 평가척도 (MVRS)



[3] 문진

유형	해당 질환 및 병태
통증 기간	- 시작시기, 심해진 시기 (출산 후 갑자기 심해졌다면 - 속발성의 가능성) - 월경기간에 따른 구분 (전후): 허실구분 (임상적 의미 x) - 지속기간: 72시간★ (72시간 법칙은 명확하게 구분해야 함.)
통증 분석	- 통증의 위치: 하복통 요통 대퇴방산통 - 성교통 여부 : 속발성 감별 (보통 자궁내막증)
통증 강도	- 평가척도 활용, 학업/일상생활의 지장, 진통제 효과 여부
통증 원인	- 스트레스(자율신경계 영향), 산과력, 과거력 (부인과 수술, 성전파성 감염 중 PID, '임질'), IUD로 인한 염증
월경 양상	- 월경주기, 성상 (양, 색, 질, 혈괴 유무) → 한열허실의 근거가 됨
동반 증상	- 복부팽만, 오심, 구토, 두통, 피로감, 성교통(자궁내막증) - 비정상자궁출혈(점막하 자궁근종, 자궁내막용종), 복부냉감(수족냉증도 체크)
² 소증	- 소화, 대소변, 수면 등
연령	- 연령에 따른 호발 기저질환 (정확한 기준은 아님) - 25세 이하: 원발성 - 25세 이후: 속발성 가능성 - 30세 이후: 자궁근종, 자궁샘근증 가능성
결혼 여부	- 출산력, 유산력, 스트레스 → 임신, 출산은 감쇠요인
³ 약물 복용	- 진통제 복용기간 및 복용량 문진 필수 사항(총 진통제 복용 개수, 월경기간 중 언제 복용하는지, 의사의 진단으로 복용하는지, 어떤 약을 복용하는지 등 자세하게 물어봐야 함.)
기존 치료	- 치료 내용과 반응, 부작용 등

- ① 임질: 남성은 농노 등 증상이 뚜렷한데 반해 여성은 잠복성 질환으로 넘어가는 경우가 많음. 임질균이 난관까지 침범하여 자궁외임신 등을 한 후에야 자신이 임질이 있었다는 사실을 알게 되는 경우도 있음.
+) 클라미디아 감염: 난관에 염증이 발생했음에도 본인이 클라미디아 앓고 있다는 사실을 모르는 경우가 훨씬 더 많음.
- ② 소증 : 한습응체, 기체혈어 등 실증이 많으며, 소화기계 증상이 나타남.
- ③ 약물 복용 : 속발성은 통증이 심한 편인데, 정말 심한 경우 마약성 진통제까지 복용하는 경우도 O

[4] 절진 및 설진 - 교과서 보고 참고하라고 하고 넘어가심.

부위/검사법	파악사항
복진	통증 부위 / 압통 여부 통증 부위를 누르거나 마사지 시 통증의 완화 여부 (희안 거만 여부)
맥진	대표 맥상
설진	설체의 색, 윤택 및 질 (두께, 크기, 어점, 치흔) 설태의 색, 밀도, 윤택의 정도

[5] 망진

부위/검사법	파악사항
월경혈	- 월경혈의 양상
얼굴	- 얼굴 혹은 기타 신체피부 및 조갑의 색과 윤택 정도
초음파	- 자궁 크기와 형태 - 자궁 및 부속기의 종괴 - 자궁 내강의 용종 및 왜곡 유무 (자궁선근증, 자궁근종 환자는 치료 경과를 보려고 초음파를 실시하기도 함)
복강경	- 유착 및 이소성 내막 착상 소견 (교과서에는 복강경을 PID의 최종 진단으로도 사용한다고 하지만, 실제로는 진단보다는 수술의 목적으로 사용함)

[6] 변증진단

- 실증: 기체혈어, 한습응체
- 허증: 기혈허약, 간신히손

[7] 상병진단

- 통증의 주기적 양상 확인 (비주기적 골반통 배제)
- 자궁의 기질적 원인 감별

보통 초음파를 가장 많이 사용하며, 자궁경검사, 자궁내막조직검사는 일반적이지 않음.

일반혈액검사는 염증소견(WBC 수치), PID가 의심되면 CRP, ESR(적혈구 침강속도)등의 염증 표지를 확인함.



※ 종양표지자 Tumor Marker (Antigen, Protein, Enzyme)

- ① tumor marker : 종양이 있을 때 종양 자체에서 또는 인체의 반응으로 생성되는 물질 (호르몬, 단백질, 항원 등으로 형태는 다양)
- ② 부인과적으로 중요한 종양표지자

★ CA125	난소의 기질적 문제를 시사 주로 장액성 난선암의 종양표지자로, 자궁내막종의 치료 평가도구로 사용 - 높게 나온다고 무조건 난소암과 같은 병변을 의미하지는 않음.
SCCAg	= 편평세포암항원(Squamous cell carcinoma related antigen) → 자궁경부암에 활용 (폐암, 식도암 등에서도 상승)
★ HE4	= Human Epididymis protein 4, 인간부고환단백 → 난소암에 활용 (CA125보다 난소암에 더 특이적)
CA15-3	유방암 확인용

- ③ 타 과에서 사용하는 종양표지자들 (알아둘 필요있음. 건강검진표에서 많이 나옴)
αFP(간) / CEA(소화기-대장, 위장관) / PSA(전립선 특이항원 - 전립선암) / NMP22(방광암 표지) / CA19-9(췌장 특화된 종양표지자) / Cyfra21-2(폐)

[8] 감별진단

★ 급성복통을 야기하는 원인 중 혈복강을 일으킬 수 있는 난소의 낭종은 (황체낭종)이다. '05

1) 비정상 임신 - 난관임신 ★

- 자궁외 임신: 복통 / 무월경 / 질 출혈(점상출혈, 반드시 발생 x)
→ 초음파, B-hCG 연속적 측정으로 검사

2) 난소낭종 파열 - 난포낭종, 황체낭종, 루테인낭종

A. 난포낭종: 배란 이상으로 발생

- ① 기능성 난소낭종: 난자의 미성숙으로 인한 배란장애로, 배란이 양쪽 난소가 아닌 일측에서만 되므로 한쪽에만 낭종이 생김. 낭종 사이즈는 크지 않으며, 있다가도 없고 없다가도 있음. (가만히 있어도 없어지기도 함)
- ② 난포성 난소낭종: 배란 장애가 있으며, 난포가 증대되는 양상을 띠며, 기능성과 같이 일측성으로 생김.

B. 황체낭종: 대부분 임신과 관련되며, 포상기태나 용모상피암 등 질병에서 증가한 hCG의 과도한 난소 자극으로 발생함. 낭종이 순식간에 커지며, 혈종이기 때문에 터지면 복강내로 피가 침범하는 '혈복강'이 발생함. 일측성이 아닌 양측성으로 발생. (다른 낭종들은 장액성 낭종, 혈종은 더 끈끈하기 때문에 스스로 잘 없어지지 않음. 따라서 크기가 커지는지 여부를 잘 보아야 함.)

C. 루테인낭종: 크기도 크고 양측성으로 발생함. 난포, 황체 낭종과 구분하기 어려움.

3) 자궁부속기염전 - 난소, 난관 주위 낭종의 경염전

원발성월경통과 비교도 안될 정도의 극심한 통증이 특징.(emergency, 견디기 어려움) 낭종이 일정 크기 이상이 되면 종양을 유지하기 위한 줄기가 생기는데 이것이 꼬인 상태로 엄청난 통증을 유발함.

4) 급성난관난소염 - PID

발열, 염증성 변화가 동반되며 배가 엄청 딱딱하여 복진시 특이점이 느껴짐.

5) 자궁근종 - 경염전

6) 위장관 병변 - 충수염, 게실염, 장폐쇄

- 충수염 : 월경 시기와 겹치는 경우 구분이 어려움 → 초음파로 구분 (충수돌기염의 초기 증상은 체했다고 생각하게됨. 팍 막힌 듯한 느낌. 이것이 점차 통증이 우하방으로 이동함.)
- 게실염 : 장의 안쪽에 있는 장막이 바깥의 근육막을 뚫고 나온 것으로, 폐경 후에 오는 경우 많음 / 근육층 약화로 발생 / 저식이섬유 섭취가 원인 / S상 결장 호발
- 장폐쇄 : 이루 말할 수 없는 통증이 생기므로 Xray 상 gas 패턴을 관찰함.
- +) 월경시 평소보다 변을 잘 보는 경향(변비인 사람도 설사에 가까워짐)

7) 요로질환 - 결석, 방광염, 신우신염

- 결석: 자통 (매우 심하며 날카로운 통증이 발생. 결석은 결정이 아주 날카로움.)
- 방광염: 소변 문제가 바로 발생
- 신우신염은 고타통

※ 월경통을 주소로 환자가 내원하면 자연스레 '월경통'으로만 생각하고 진단과 치료를 진행함. 그러나 실제로 위의 경우와 같이 다른 질환에 의한 것일 수도 있으니 꼭 상기하고 주의해야 함.

- ★ 자궁외임신이 의심될 때 초음파검사와 함께 (베타-hCG 연속적측정) 검사를 하는데 방법은 (48시간)마다 혈청 (베타-hCG)를 측정하는 것이다 '05
- ★★ 비정상임신에 있어 베타-hCG 연속적 측정의 임상적 의의에 대해 쓰시오 '04,11

※ β-hCG 연속적 측정의 임상적 의의 → 수업x 산과시간에 배웠을 것이라고만 말씀하심.

측정	- LH surge 7~9일 후 임신부의 혈장에서 완전한 hCG측정 - 혈장 농도는 매 2일 마다 두 배로 증가하여, LMP로부터 60~80일(8~10주)사이에 최고 농도에 이르게 됨 - 임신 10주~12주 사이 혈중농도 감소되기 시작하여 임신 20주 최 저농도에 이르고, 임신기간동안 유지됨 (출산 2주후 정상으로 회복)	
연속측정 의의	정상임신과 비정상임신의 감별진단에 유용 ★	
방법	48시간 후 다시 혈청 hCG를 측정함	
결과	정상임신	- 66% 이상 증가 - 6주동안 6천~1만mIU/mL까지 증가하고 70일 정도까 지 2일마다 두배로 증가
	비정상 임신	- 66% 이하로 증가 - hCG상승이 plateau 모양을 나타냄 → 자궁외 임신 or 유산의 가능성
	유산	hCG 감소